Algoritmo CIF — Rodilla

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Rodilla. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b.

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 1 si «SÍ»

1b ¿Algún criterio de Ottawa (≥55 años · cabeza del peroné · rótula aislada · no flexiona 90° · no cargó cuatro pasos ni tras la lesión ni en la consulta)? Y en toda rodilla traumática con dolor anterior, elevación de la pierna extendida. Alternativa a Ottawa: Pittsburgh — contusión o caída MÁS (<12 o >50 años, o no puede caminar); S ≈99 % con E ≈60 %, pide menos radiografías (Seaberg y Jackson 1994; Seaberg 1998).

- OTTAWA POSITIVO → 11 Fracturas (Rótula o Meseta Tibial)
- NO ELEVA LA PIERNA EXTENDIDA → sin hipótesis
- NINGUNO → sin hipótesis

SÍ

1 ¿Hubo un evento lesivo reciente con inflamación inmediata? Rodilla aguda traumática: ¿qué mecanismo cuenta?

NO

2 ¿El paciente es mayor de 45 años con rigidez matutina breve (<30 min)?

todas

2b ¿Niño o adolescente con dolor de rodilla sin mecanismo conocido? → EXPLORAR PRIMERO LA CADERA (epifisiólisis, Perthes). Solo si el cribado es normal, seguir en la rodilla.

SÍ — Sensación de "pop", derrame articular rápido e inestabilidad (posible LCA) → 4 Lesión del Ligamento Cruzado Anterior (LCA) → desvío 1b

SÍ — Trauma rotacional con síntomas de bloqueo o chasquidos (posible Menisco) → 2 Lesión Meniscal → desvío 1b

SÍ — Valgo con el pie fijo → LCM (mirar LCA y menisco medial) → 8 Lesión del Ligamento Colateral Medial (LCM) → desvío 1b

SÍ — Golpe en tibia anterior con rodilla flexionada (salpicadero) → LCP y EPL → 9 Lesión del Ligamento Cruzado Posterior (LCP) → desvío 1b

SÍ — Golpe anteromedial o varo cerca de la extensión → LLE y EPL → 10 Lesión del Ligamento Lateral Externo y Esquina Posterolateral (LLE y EPL) → desvío 1b

SÍ — La rótula «se salió», aprensión al trasladarla lateralmente → INESTABILIDAD ROTULIANA → 12 Inestabilidad Rotuliana → desvío 1b

SÍ — Golpe directo anterior, dolor con extensión resistida, escalón palpable → FRACTURA → 11 Fracturas (Rótula o Meseta Tibial) → desvío 1b

NO — Dolor de inicio insidioso o crónico → sin hipótesis

SÍ — Edad ≥45 años, dolor relacionado con actividad, rigidez <30 minutos → 1 Artrosis de Rodilla

NO — Perfil más joven o sin patrón degenerativo → sin hipótesis

SÍ — Cribado de cadera alterado: derivar (epifisiólisis, Perthes) → sin hipótesis

SÍ — Cribado de cadera normal: seguir en la rodilla → sin hipótesis

NO — Adulto, o hay mecanismo conocido → sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 2c, en la página siguiente →

↓ Paso 2c: viene del paso 2b

2c ¿Reproduce el dolor de rodilla la exploración de la cadera o de la columna lumbar?

- **CADERA (artrosis)** — Tratar el origen: valorar en la región Cadera → sin hipótesis
- **COLUMNA LUMBAR (radiculopatía o pseudorradiculopatía)** — Tratar el origen: valorar en la región Lumbar → sin hipótesis
- **NO** — Ninguna de las dos reproduce el dolor de rodilla → sin hipótesis

todas →

3 ¿En qué zona se concentra el dolor de rodilla?

- **Anterior/Retrorrotuliano** — Dolor al cargar en flexión (escaleras, sentadilla) en <40 años → 3 Dolor Patelofemoral (Síndrome)
- **Anterior/Polo inferior rótula** — Dolor exacto en polo inferior, vinculado a saltos o frenadas → 5 Tendinopatía Rotuliana
- **Lateral** — Dolor en cóndilo femoral lateral que empeora al correr → 6 Síndrome de la Banda Iliotibial
- **Medial/Distal** — Dolor 2 cm distal a meseta tibial medial, empeora al subir escaleras → 7 Bursitis de la Pata de Ganso
- **NINGUNA de estas** — Seguir por zona → sin hipótesis

todas →

4 Dolor persistente o sin traumatismo, ANTERIOR: ¿qué lo explica?

- **HOFFA** — Recurvatum, test de Hoffa → 13 Síndrome de la Grasa de Hoffa
- **BURSITIS PRERROTULIANA** — Superficial, arrodillarse → 14 Bursitis Pre e Infrarrotuliana
- **INESTABILIDAD ROTULIANA** — Fallo, aprensión → 12 Inestabilidad Rotuliana
- **LESIÓN OSTEOCONDRAL** — Bloqueo → 16 Lesión Osteocondral
- **APOFISITIS POR TRACCIÓN** — En menores → 15 Apofisitis del Adolescente (Osgood-Schlatter, Sinding-Larsen-Johansson)
- **NINGUNO** — Sin dolor anterior o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 5 ↓

↓ Paso 5: viene del paso 4

5 Dolor persistente o sin traumatismo, MEDIAL: ¿qué lo explica?

- **MENISCO MEDIAL** → 2 Lesión Meniscal
- **ARTROSIS** — Criterios ACR → 1 Artrosis de Rodilla
- **PLICA MEDIAL** → 17 Plica Sinovial Medial
- **NINGUNO** — Sin dolor medial o nada de esto lo explica → sin hipótesis

todas →

6 Dolor persistente o sin traumatismo, LATERAL: ¿qué lo explica?

- **TIBIOPERONEA PROXIMAL** → 18 Disfunción de la Articulación Tibioperonea Proximal
- **MENISCO LATERAL** → 2 Lesión Meniscal
- **NERVIO PERONEO COMÚN** → 19 Neuropatía del Nervio Peroneo Común
- **NINGUNO** — Sin dolor lateral o nada de esto lo explica → sin hipótesis

todas →

7 Dolor persistente o sin traumatismo, POSTERIOR: ¿qué lo explica? Descartada siempre la TVP.

- **QUISTE POPLÍTEO** — Signo de Foucher → 20 Quiste Poplíteo (Baker)
- **LCP CRÓNICO** → 9 Lesión del Ligamento Cruzado Posterior (LCP)
- **COLUMNA LUMBAR** — Tratar el origen: valorar en la región Lumbar → sin hipótesis
- **NINGUNO** — Sin dolor posterior o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor rodilla inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.